



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نعمات عبدالله أحمد زايد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 24805271200586 رقم التليفون : 01006537253
العنوان : --
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-05-1948 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان القولون
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان القولون
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6159] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: نعمات عبدالله أحمد زايد
National ID: 24805271200586



تقرير طبي

المسجد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- -- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

A patient of colon cancer for Supportive and palliative Treatment

الوقت :

-- --

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

2011

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "VCO" and some illegible scribbles.

卷之五

محمد بن عبد الله
 بن عبد الله بن عبد الله
 بن عبد الله بن عبد الله

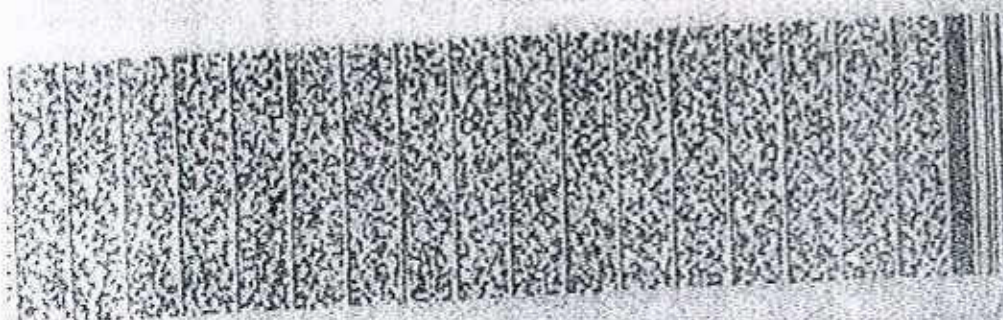
770

٢٠٢١/٠١ ٢٤٨٠٥٢٧١٢٠٠٥٨٦
ر.ب. منزل

أنثى مسلمة أرملة



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠١/٠٤

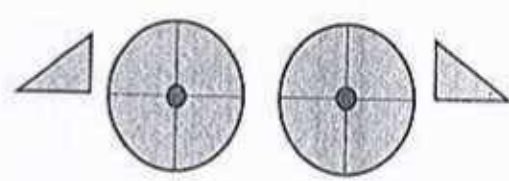


MDT FORM

18/2/2026 G

Name	رانيا عبد الله احمد	MRN	040/CCT
Age	78 yrs	ID	
Menopausal status		Phone	0100 653725
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	Epilepsy on Depakine		
REASON OF MDT			

Clinical Data

BX:				R L  TNM
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:	
Sonomammography:				
Mets Workup:				

Pt is (not) Present / PS = 1 (by pt's daughter who

Recommendations:

- pt is presented by Anaemia Hb: 7
 - wt loss, fatigue, Abdominal Pain
 -> Colonoscopy -> Sigmoid Mass -> Adenocarcinoma
 -> CT PA -> Sigmoid Mass + HFLs -> RAS -> wild type
 -> Started outside (9) cycles Vectribex, Xelox

MDT OUTCOME & PLAN

(Private basis) Evaluation -> SD -> she continues on public basis

MDT -

Vectribex + Xelox

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
See Oncology	Dr. Elmaghrabi				



معامل الخلية لتحليل الأنسجة والأورام

Patient Name	نعمات عبدالله احمد زايد	Code Number	YK 25038968
Sex/Age	Female 77 Y 0 M 0 D	Patient ID	76113
Registered Date	24/11/2025 06:13:00 PM	Referred By Dr.	اكرامى سيد عثمان
Validation Date	30/11/2025 04:58:16 PM	Branch	الفرع الرئيسي الدقي
Reporting Date	30/11/2025 10:34:52 PM		

Clinical Diagnosis: Hepatic Focal Lesion
Nature of the specimen: U/S Guided TCNB

Pathology Report

Gross Picture

A case of hepatic focal lesion ?? metastasis from where U/S guided TCNB was taken for histopathological assessment.

Microscopic Picture

Sections examined from liver tissue core revealed metastatic mucinous adenocarcinoma. The tumor forms irregular glands with cribriform pattern and sheets of anaplastic cells floating in mucin pools.

Diagnosis

Hepatic Focal Lesion, U/S Guided TCNB:

Provisional Tissue Cores Involved By Mucinous Adenocarcinoma Deposits For Metastatic Work Up And Immunophenotyping.

Tightly Correlate With Clinical And PET-Scan Findings.

P.O

Number of slides enclosed: 1

Diagnosed by

Consultant Pathologist

Dr. Rana ElSaeed, MD

Scan Me



الفرع الرئيسي الدقي : ٢٠ شارع التحرير أمام مترو البحوث - الدقي - الدور الأول
م: ٠١١١٢٤٤٣٣٣ - ٠١١١٥٥٧١١٧ - ت: ٠٢٣٣٥٣٠٧٣



معامل الخلية لتحليل الأنسجة والأورام

Patient Name	نعمات عبدالله احمد زايد	Code Number	YK 25039624
Sex/Age	Female 77 Y 0 M 5 D	Patient ID	76113
Registered Date	29/11/2025 08:42:20 PM	Referred By Dr.	اكرامى سيد عثمان
Validation Date	30/11/2025 04:59:34 PM	Branch	الفرع الرئيسي الدقي
Reporting Date	30/11/2025 10:43:15 PM		

Clinical Diagnosis: Hepatic Focal Lesion (Known Case Of Colonic Mass)
Nature of the specimen: Immunophenotyping

Immunophenotyping

Sections are stained by

- SATb-2

Results

-SATb-2: Diffuse positive in tumor cells.

Conclusion

Hepatic Focal Lesion (Known Case Of Colonic Mass), Immunophenotyping:

Histopathology And Immunohistochemistry Of Metastatic Mucinous Adenocarcinoma Of Colorectal Origin.

Please Correlate With The Clinical History, Clinical, Endoscopic Radiologic, PET/CT Scan Findings As Well As Serum Level Of Tumor Markers.

P.O

Number of slides enclosed: 1

Diagnosed by

Consultant Pathologists

Dr. Ahmed Soliman, MD

Dr. Rana ElSaeed, MD

Scan Me



الفرع الرئيسي الدقي : ٢٠ شارع التحرير أمام مترو البحوث - الدقي - الدور الأول
م: ٠١١١٢٤٤٣٣٣ - ٠١١١١٥٥٧١١٧ - ت: ٠٢٣٣٣٥٣٠٧٣

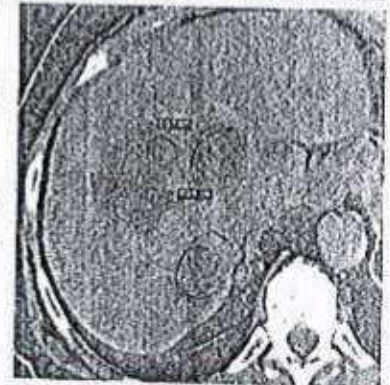
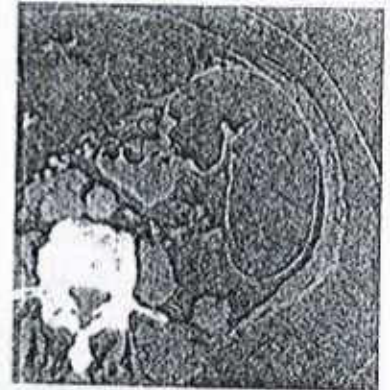
تاريخ الفحص :: 2/2/2026
كود المريض :: 656398
رقم العملية :: 12260201134
Thank you for referring this case,

الاسم :: نعمات عبدالله احمد
السن :: 77
جهة التحويل ::
الطبيب المعالج أ.د.:

MULTISLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS AFTER IV CONTRAST INTAKE WITH 2D MPR IMAGES REVEALED:

Findings:

- Stationary proximal sigmoid short segment of circumferential polypoidal wall thickening still measuring 3.6 cm in length and 0.8cm compared to 0.9 cm previously in maximum wall thickness, forming an annular mass with stricture formation. Newly developed partial colon obstruction shows moderate colonic distention proximal to mass and colonic collapse distal to mass.
- The annular mass still shows focal infiltration of the pericolic fat.
- Stable few related pericolic prominent lymph nodes largest measuring 7mm, likely metastatic.
- The liver is mild enlarged shows multiple bilobar hypodense metastatic focal lesions, the largest seen in segment 8 measuring 4.3x 5.3 cm compared to 4.3 x 5 cm previously.
- No intra or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent and homogenously enhancing portal vein and its branches.



أ.د. ناهدا عبد الوهاب

أستاذ الأشعة - جامعة القاهرة

تاريخ الفحص :: 2/2/2026	نعمات عبدالله احمد	الاسم ::
كود المريض :: 656398	77	السن ::
رقم العملية :: 12260201134		جهة التحويل ::
Thank you for referring this case,		الطبيب المعالج أ.د.:

- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, aorta and IVC.
- Both kidneys show normal size and shape. No stones or hydronephrosis.
- Regular filling of the urinary bladder shows no stones, masses or diverticula.
- Status post TAH-BSO shows clear operative bed.
- Few right external iliac calcified lymph nodes likely calcified granulomas.
- No ascites.
- Atheromatous calcifications of the Aorta and its branches.
- Degenerative changes of the scanned spine. L4 mild degenerative spondylolisthesis.
- Scanned lung bases are clear.

Impression:

- Stationary course regarding the proximal sigmoid neoplastic annular mass and the hepatic metastases.
- Newly developed partial obstruction.

Dr. Mohamed Reyad
Radiology Consultant

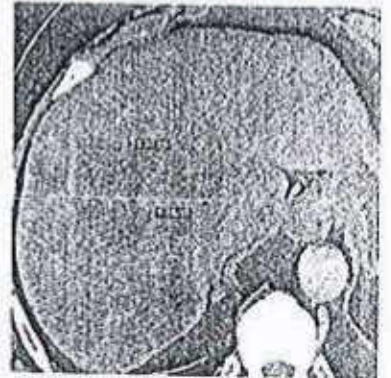
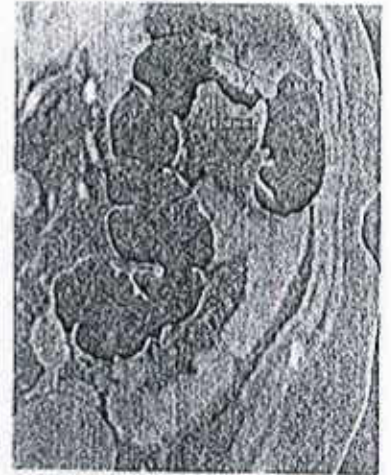
أ.د. فاطمة عبد الوهاب
أستاذة الأشعة - جامعة القاهرة

الاسم: .. نعمات عبدالله احمد
السن: .. 77
جهة التحويل: ..
الطبيب المعالج أ.د.: .. حربي رمزي سالم
تاريخ الفحص: 15/11/2025
كود المريض: 656398
رقم العملية: 12251113091
Thank you for referring this case,

MULTISLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS AFTER IV CONTRAST INTAKE WITH 2D MPR IMAGES REVEALED:

Findings:

- Proximal sigmoid short segment of circumferential polypoidal wall thickening measuring 3.6 cm in length and 0.9 cm in maximum wall thickness, forming an annular mass with stricture formation.
- The annular mass shows focal infiltration of the pericolic fat.
- Few related pericolic prominent lymph nodes largest measuring 7mm, likely metastatic.
- The liver is mild enlarged shows multiple bilobar hypodense metastatic focal lesions, the largest seen in segment 8 measuring 4.3 x 5 cm.
- No intra or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent and homogenously enhancing portal vein and its branches.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, aorta and IVC.
- Both kidneys show normal size and shape. No stones or hydronephrosis.
- Regular filling of the urinary bladder shows no stones, masses or diverticula.
- Status post TAH-BSO shows clear operative bed.



أ.د. دأود عبد الوهاب

أستاذ الأشعة - جامعة القاهرة

تاريخ الفحص :: 15/11/2025
كود المريض :: 656398
رقم العملية :: 12251113091
Thank you for referring this case,

الاسم :: نعمات عبدالله احمد
المرضى :: 77
جهة التحويل ::
الطبيب المعالج أ.د. :: حربي رمزي سالم

- Few right external iliac calcified lymph nodes likely calcified granulomas.
- No ascites.
- Atheromatous calcifications of the Aorta and its branches.
- Degenerative changes of the scanned spine. L4 mild degenerative spondylolisthesis.
- Scanned lung bases are clear.

Impression:

- Proximal sigmoid neoplastic annular mass with hepatic metastases.

Dr. Mohamed Reyad
Radiology Consultant

Colonoscopy Report

Name: نعمات عبد الله زايد

ID: 6884

Date: Wednesday 12, November 2025

Age: 76

Referring Physician:

Dear Prof. Harby Ramzy,

Thank you for referring the

Indications

Anaemia.

Medications

Propofol

Instrument

OLYMPUS CF 260 L

Findings:

BBPS (2/3)

Colonoscopy was done up to sigmoid colon shows large circumferential mass, with ulcerations, easily to bleed on touch, friable, causing narrowing of the lumen, the scope could not pass the stricture, multiple biopsies were taken for HPE.

With retroflexion of the scope at the anal canal revealed two cords of medium sized internal haemorrhoids with internal tags.

Conclusion

Sigmoid colon mass , most probabaly neoplastic for histopathological examination.

Internal haemorrhoids

Recommendation

Check biopsies result

PET CT Scan

استاذي الجليل المرحوم

Signature Amr Moustafa

تلفون : 01099499592

• ۱۲۱۱۵۱۶۶۶ : ۱۲۱۱۵۱۶۶۶

تلفون : ۰۲۲۲۵۷۲۴۳ ، ۰۱۱۵۲۴۶۰۲۲۵۰ ، فاكس : ۰۲۲۲۵۷۲۴۹

حطوان: 46 شارع شريفه امام مترو حطوان

مصدر الجديدة: ٢٠ نبيل الوفاء أمام شركة الكهرباء

الدقي : ٢ من التحرير امام منرو البحوث الدقي الجيزه



تَحِيَّاتٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

بشأن تقرير طبي للمريض: []

إهداء الطالب المقدم من .

رقم طبي

نَشْرُفُ بَانَ نَوْضَحُ فِيمَا لِي تَقْرِيرَا عَنْ حَالَتِهِ :

تاريخ ومساحة الخروج.

تاريخ وساعة الدخول.

وبين الكفيف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

مجلس الشورى في 19/9

5531 The Great

وہاں الیورس کا ماس

For Cite.

2005/5

C-179/03

۱۰۰

التاريخ :

.....

الطبيب المعالج

بیستم

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحتة طبية وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض: لجبات عبدالمحاج ن

إيماء الطالب المقدم من

رقم طبي

تتخرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

و/ص عين حمر اللون، وأولاً لا يرى
أرضه و كتابه أي خط خارج
FOFOFI ماذا كجيا (Sama)

دارينيا و صله

C.C/9/C4

تحريراً في

التاريخ: / / الوقت:

الطبيب المعالج

يعتمد ،،

Name: Nemat Abdullah Ahmed

Date: 8/9/2026
ID: 30204172

F18-FDG PET/CT STUDY

Clinical History:

- 78 years old female patient presented with metastatic mucinous adenocarcinoma.

Reason for PET/CT study:

- follow up

Technique:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: previous PET-CT dated: 21/5/2026

FINDINGS:

Head and Neck:

- No hyper-metabolic FDG avid cervical LNDs
- still seen Enlarged heterogenous thyroid gland with focal retrosternal extension with multiple non metabolic active nodules and calcified foci.
- Prominent FDG avid left lingual and left palatine tonsils , for clinical correlation.
- Physiologic FDG uptake is seen in the salivary glands, and larynx.
- Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Chest:

- **stationary** Multiple non FDG avid small pretracheal, right paratracheal, aorto-pulmonary, pre and subcarinal LNs the largest measures about 1 cm.
- stable Few small calcified left axillary nodules.
- There is no hypermetabolic axillary lymphadenopathy.
- Newly developed metabolic active left pulmonary nodules, largest is seen at superior lingular segment measures 6mm with SUVmax~1.9.
- Few bilateral upper lung lobes tiny pulmonary and fissure based nodules are noted.
- NO FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- progression of Non uniform circumferential mural thickening seen involving the hepatic flexure with maximum thickening about 3cm with SUVmax~14.5 (compared to 1.9cm of SUVmax~8.4), with



luminal narrowing seen associated with progression of fat stranding and multiple small sub-centimetric soft tissue nodules/nodes.

- progression of Non uniform mural thickening seen involving short segment of the proximal and mid descending colon with fine fat stranding, reaching maximum thickening about 1.8cm with SUVmax~15.2 (compared to 1.4cm of SUVmax~8.4).
- progression of Mild FDG avid mural wall thickening noted over splenic flexure of SUVmax~15.3 (Vs SUVmax~8.6).
- still seen Mildly enlarged porto-caval LN measures 1.6x0.8cm is noted of SUVmax~3 (Vs SUVmax~2.8).
- stable Multiple calcified right common, internal and external iliac LNs are noted the largest measures 1.4x0.5cm
- The liver is average size showing marked progression of multiple FDG avid hypodense focal lesions, the largest seen at segment VIII measures about 10x15cm with SUVmax~16.2 (compared to 5x3.6cm of SUVmax~10.1), of metastatic nature.
- The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- Prominent left suprarenal gland, with no active adrenal nodules.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.
- Spondylo-degenerative changes are noted.

WWW.57357.ORG
رحلة علم صحتنا الحية

مركز شبكة العظام - السيدة زينب - القاهرة

د. خالد الدين - مدير

تلف : 19057 (202)

فكس : 25 35 1745 (202)

57357EG

1 Selket Al-Emann st, El Sayda Zainab, Cairo

P.O. Box 1 El Dawawin, Egypt

Tel: (202) 19057

Fax: (202) 25 35 1745

E-mail: info@57357.org



Egypt
Cancer Network
USA



Egypt
Cancer Network
Canada



Egypt
Cancer Network
Saudi Arabia



CamScanner

IMPRESSION:

Follow up PET-CT study showing:

- ❖ Progression of FDG avid multi-focal colonic neoplastic mural wall thickening;
- ❖ Progression of FDG avid active metastatic hepatic focal lesions.
- ❖ Newly developed metabolic active left pulmonary nodules; likely metastatic.

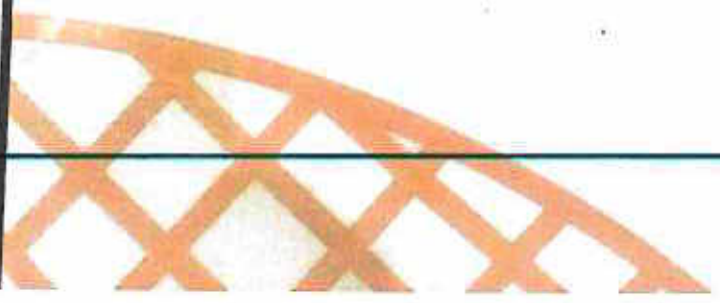
Thanks for referral,

Mona Marai, MD

Aya Ashraf, MD

Radiology Consultant

Nuclear Medicine Consultant



تحية طيبة وبعد،،،

بشأن تقرير طبي للمريض: []

إهداء الطالب المقدم من .

رقم طبي

نَشْرُفُ بَانَ نَوْضَحُ فِيمَا لِي تَقْرِيرَا عَنْ حَالَتِهِ :

تاريخ وساعة الخروج.

تاريخ وساعة الدخول.

وبين الكفيف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

مجلس الشورى في 19/9

5531 The Great

وہاں الیور کا مسم

For Cite.

2005/5

C-17/9/23

۱۰۰

التاريخ:

.....

الطبيب المعالج

بیستم

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تخية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض: لجبات عبدالمعاج ن

إيماء الطالب المقدم من

رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

و/ص عين حمر اللون، وأحياناً أكثر
أزرق و كآج اي حط خلاص
FOLFORT ماذا كجيا (Sema)

دارينيا ودهل

C.C/9/C4

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج

يعتمد ،،

Name: Nemat Abdullah Ahmed

Date: 8/9/2026

ID: 30204172

F18-FDG PET/CT STUDY

Clinical History:

- 78 years old female patient presented with metastatic mucinous adenocarcinoma.

Reason for PET/CT study:

- follow up

Technique:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: previous PET-CT dated: 21/5/2026

FINDINGS:

Head and Neck:

- No hyper-metabolic FDG avid cervical LNDs
- still seen Enlarged heterogenous thyroid gland with focal retrosternal extension with multiple non metabolic active nodules and calcified foci.
- Prominent FDG avid left lingual and left palatine tonsils , for clinical correlation.
- Physiologic FDG uptake is seen in the salivary glands, and larynx.
- Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Chest:

- **stationary** Multiple non FDG avid small pretracheal, right paratracheal, aorto-pulmonary, pre and subcarinal LNs the largest measures about 1 cm.
- stable Few small calcified left axillary nodules.
- There is no hypermetabolic axillary lymphadenopathy.
- Newly developed metabolic active left pulmonary nodules, largest is seen at superior lingular segment measures 6mm with SUVmax~1.9.
- Few bilateral upper lung lobes tiny pulmonary and fissure based nodules are noted.
- NO FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- progression of Non uniform circumferential mural thickening seen involving the hepatic flexure with maximum thickening about 3cm with SUVmax~14.5 (compared to 1.9cm of SUVmax~8.4), with



luminal narrowing seen associated with progression of fat stranding and multiple small sub-centimetric soft tissue nodules/nodes.

- progression of Non uniform mural thickening seen involving short segment of the proximal and mid descending colon with fine fat stranding, reaching maximum thickening about 1.8cm with SUVmax~15.2 (compared to 1.4cm of SUVmax~8.4).
- progression of Mild FDG avid mural wall thickening noted over splenic flexure of SUVmax~15.3 (Vs SUVmax~8.6).
- still seen Mildly enlarged porto-caval LN measures 1.6x0.8cm is noted of SUVmax~3 (Vs SUVmax~2.8).
- stable Multiple calcified right common, internal and external iliac LNs are noted the largest measures 1.4x0.5cm
- The liver is average size showing marked progression of multiple FDG avid hypodense focal lesions, the largest seen at segment VIII measures about 10x15cm with SUVmax~16.2 (compared to 5x3.6cm of SUVmax~10.1), of metastatic nature.
- The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- Prominent left suprarenal gland, with no active adrenal nodules.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.
- Spondylo-degenerative changes are noted.

WWW.57357.ORG
رحلة علم صحتنا الحية

مركز شبكة العظام - السيدة زينب - القاهرة

د. ب. : الدكتور - مصر

تلف : (202) 19057

فكس : (202) 25 35 1745

البريد الإلكتروني : info@57357.org



USA



Cairo



Referral



CamScanner

IMPRESSION:

Follow up PET-CT study showing:

- ❖ Progression of FDG avid multi-focal colonic neoplastic mural wall thickening;
- ❖ Progression of FDG avid active metastatic hepatic focal lesions.
- ❖ Newly developed metabolic active left pulmonary nodules; likely metastatic.

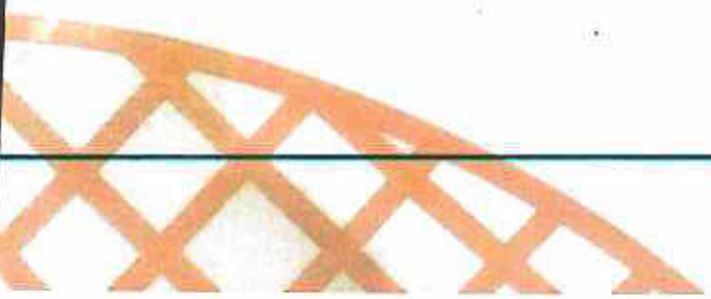
Thanks for referral,

Mona Marai, MD

Aya Ashraf, MD

Radiology Consultant

Nuclear Medicine Consultant



www.57357.org
موقع علم صمعا الحديث

1 Setet Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057

www.

www.

موقع سكة العلم - السجدة زينة - القاهرة
موقع الدواوين - مصر